

低频脉冲电刺激联合针灸治疗对脑瘫儿童合并 吞咽障碍患者的临床效果评价

刘 东, 王 耀*, 倪之媛, 李晓文, 曹 冉
(宿迁市宿城区人民医院康复科, 江苏 宿迁 223800)

【摘要】目的 探究低频脉冲电刺激联合针灸治疗对脑瘫儿童合并吞咽障碍患者的临床效果评价。
方法 选取2018年1月~2018年12月间我院收治的脑瘫合并吞咽功能障碍的患者40例作为研究主体, 采用信封法进行分组, 实验组20例患儿采用低频脉冲电刺激联合针灸治疗, 对照组20例患儿采用针灸治疗, 对比两组患儿吞咽功能评分。**结果** 实验组患儿的吞咽功能评分显著低于对照组, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$)。**结论** 低频脉冲电刺激联合针灸治疗脑瘫儿童合并吞咽障碍患儿已经在临床中取得了良好的效果, 该种治疗方式值得推广。

【关键词】 低频脉冲电刺激; 针灸; 脑瘫; 吞咽障碍

【中图分类号】 R743.3

【文献标识码】 A

【文章编号】 ISSN.2095-8242.2019.62.40.01

DOI:10.16281/j.cnki.jocml.2019.62.033

脑瘫是指从出生后一个月内脑部尚未发育成熟, 脑瘫属于非进行性脑损伤, 可使脑部多个神经组织受到累及, 患儿常表现为智力缺陷, 癫痫行为异常, 吞咽功能障碍等。若脑瘫患儿长期处于吞咽功能障碍状态中, 则会导致患儿进一步发生营养不良、脱水等, 会使患儿的病情进一步加重, 影响其生活^[1]。因此, 本文主要探究低频脉冲电刺激联合针灸治疗对脑瘫儿童合并吞咽障碍患者的临床效果, 具体探究结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为40例我院收治的脑瘫合并吞咽功能障碍患儿, 研究对象选取时间为2018年1月~2018年12月, 分组依据为信封法, 实验组与对照组患儿各20例。实验组患者中, 男性患者为11例, 女性患者为9例, 患者的年龄为3~10岁, 平均年龄为(6.27±1.01)岁, 对照组患者中, 男性患者为10例, 女性患者为10例, 患者的年龄为2~10岁, 平均年龄为(5.98±1.42)岁, 两组患儿的年龄、性别等数据对比, 差异不具有统计学意义 ($P>0.05$)。

1.2 方法

对照组患儿仅采用针灸疗法治疗, 主要施针穴位为廉泉穴、双池穴、夹廉泉穴、百劳穴、金津穴、玉液穴等穴位, 廉泉穴、夹廉泉穴由舌根方向进针, 采用插捻手法, 金津穴、玉液穴施针后得气后, 再使用重手提插捻转法, 其余穴位采用平补平泻法, 每天治疗一次, 每周进行5次针灸治疗即可。

实验组采用低频脉冲电刺激联合针灸治疗, 针灸治疗方法与对照组患者相同, 使用仪器为脑电仿生电刺激仪器, 设置频率为50 Hz, 使用的功率为35 VA, 应将电极先放置于患儿的舌骨上方, 使用通道I电极, 将患侧面颊部防止通道II电极; 打开电源进行操作, 间接增加两个通道的振幅, 振幅最大的强度在患者可承受范围内即可, 应使用保持水平刺激, 同时嘱患儿做空吞咽动作, 每次济宁2次治疗, 每天进行半小时。

1.3 观察指标

对比两组患儿吞咽功能评分。吞咽功能评分采用日本花田是因水实验进行判断, 若患儿取坐位, 饮水30 ml, 一次性喝下, 并且不存在呛咳现象, 记0分; 可分两次完成, 引水期间未出现呛咳停顿, 记1分, 可将30 ml一次性饮完, 但出现呛咳停顿现象, 记2分; 可分两次饮完水, 并出现停顿, 呛咳, 记3分; 盐水30 ml过程中频繁出现停顿和现象, 不能将水全部咽下, 记4分。得分越低患儿的吞咽功能恢复越好。

1.4 统计学分析

采用SPSS 17.0软件计算40例脑瘫合并吞咽功能障碍的儿童, 吞咽功能评分用(均数±标准差)的形式表示, 行 t 检验, 当数据对比呈现为 $P<0.05$ 的差异性时, 统计学意义存在。

2 结果

两组患儿的吞咽功能评分对比, 实验组患儿的吞咽功能评分显著低于对照组, 差异具有统计学意义 ($P<0.05$), 见表1。

表1 两组患儿的吞咽功能评分对比 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	n	吞咽功能评分
实验组	20	2.14±0.02
对照组	20	3.46±0.14
t	-	51.1233
P	-	0.0000

3 讨论

脑瘫是婴幼儿时期的一种脑部发育障碍性疾病, 常与吞咽功能障碍共同发生, 会使患儿的生长发育受到影响。脑瘫多由外界因素引起, 在给予患儿有效的治疗时, 应配合相应康复训练, 可使脑瘫患儿吞咽功能障碍等症得到有效改善, 降低疾病对患儿生长发育的影响, 提高生活质量^[2]。

当下临床中常采用针灸疗法对患儿的穴位进行针刺, 通过穴位刺激可促进血液微循环, 使经络的气流得以疏通, 从而使患儿口部肌群功能得以改善, 并能够使患儿脑瘫症状有所缓解, 同时经过穴位刺激, 可达到调节脏腑养心益肾的功效。低频脉冲电刺激联合针灸治疗脑瘫, 可对针灸的治疗效果起到促进作用, 通过电流刺激可加快面部血液循环, 并对咽喉部以及口腔部肌肉产生刺激, 形成吞咽性条件反射, 最终达到改善患儿吞咽功能障碍的目的^[3]。

综上所述, 低频脉冲电刺激联合针灸治疗脑瘫儿童合并吞咽障碍效果显著, 可改善患儿面部、喉部肌群功能, 提高患儿吞咽能力。

参考文献

- [1] 刘 攀. 针灸联合按摩在小儿脑瘫合并吞咽障碍患者治疗中的应用[J]. 临床医药文献电子杂志, 2016, 26(53): 85-86.
- [2] 刘晓璟. 观察针灸联合按摩治疗脑瘫合并吞咽障碍的临床效果[J]. 临床研究, 2017, 25(7): 172-173.
- [3] 林 桦. 针灸联合按摩治疗脑瘫合并吞咽障碍的临床研究[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2017, 16(19): 25-26.

本文编辑: 吴 卫

通讯作者: 王 耀